

Masterclass de Cirugía General

ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

Guía Definitiva de Diagnóstico y Manejo



BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok

EL MARCO DIAGNÓSTICO: MÉDICO VS. QUIRÚRGICO

Abdomen Agudo Médico

Resolución farmacológica.
¡NO requiere cirugía!

- Cetoacidosis diabética
- IAM de cara diafragmática (simula dolor epigástrico)
- Neumonía basal
- Infección del tracto urinario
- Hepatitis / Hepatomegalia congestiva

Abdomen Agudo Quirúrgico

Resolución operatoria de emergencia.
Riesgo vital inminente.

- Preparación inmediata
- Accesos venosos periféricos
- Corrección hidroelectrolítica
- Tipificación sanguínea

REGLA DE ORO: Estabilización preoperatoria guiada por el protocolo ERAS.



LOS 5 PILARES DEL ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

Clasificación Clínica Fundamental



INFLAMATORIO

- Apendicitis
- Colecistitis
- Diverticulitis
- EPI



HEMORRÁGICO

- Embarazo ectópico roto
- Aneurisma aórtico roto
- Pancreatitis necrohemorrágica



OBSTRUCTIVO

- Vólvulos (sigmoideo/cecal)
- Bridas y adherencias
- Hernias incarceradas
- Invaginaciones



PERFORATIVO

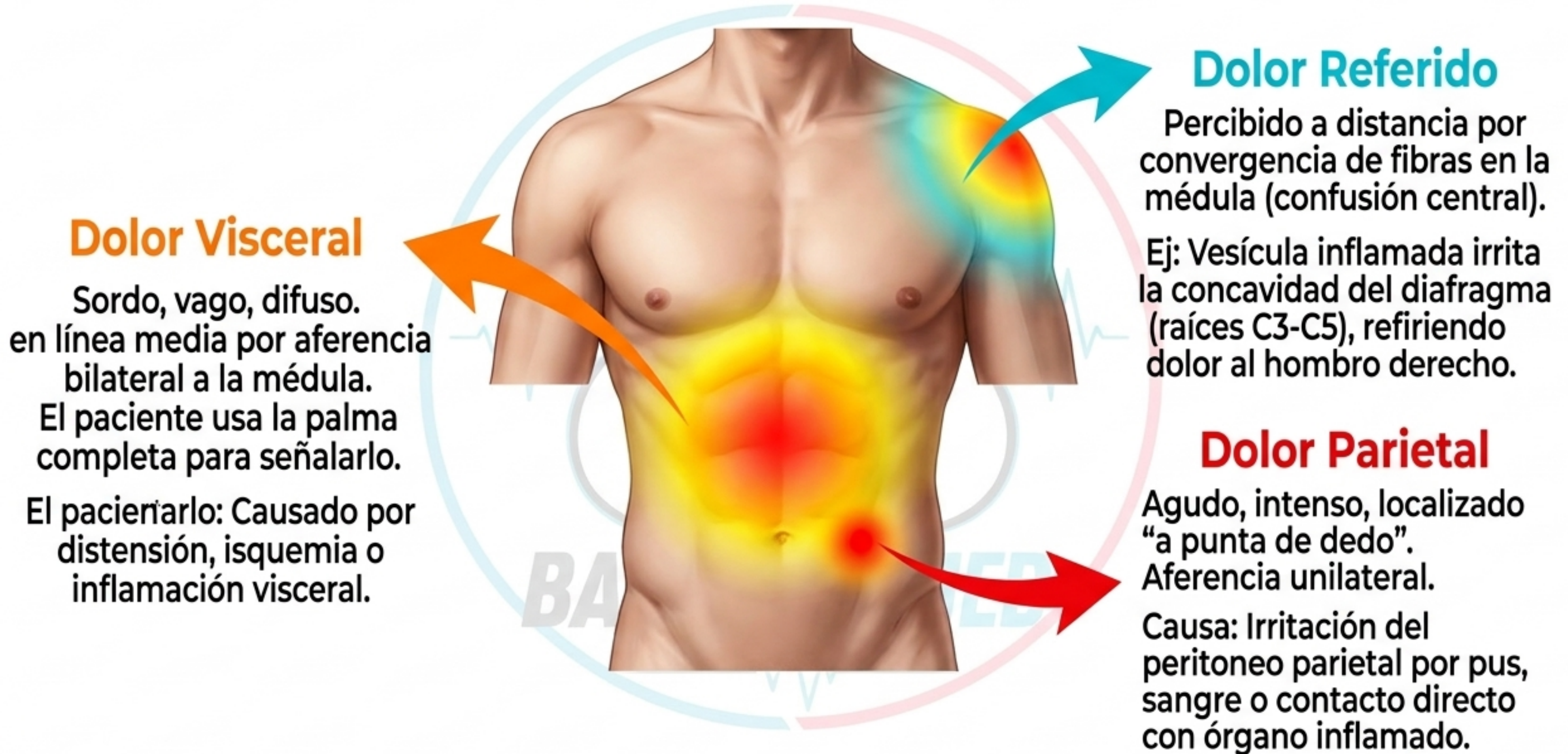
- Úlcera GI perforada
- Divertículo perforado
- Tumor perforado



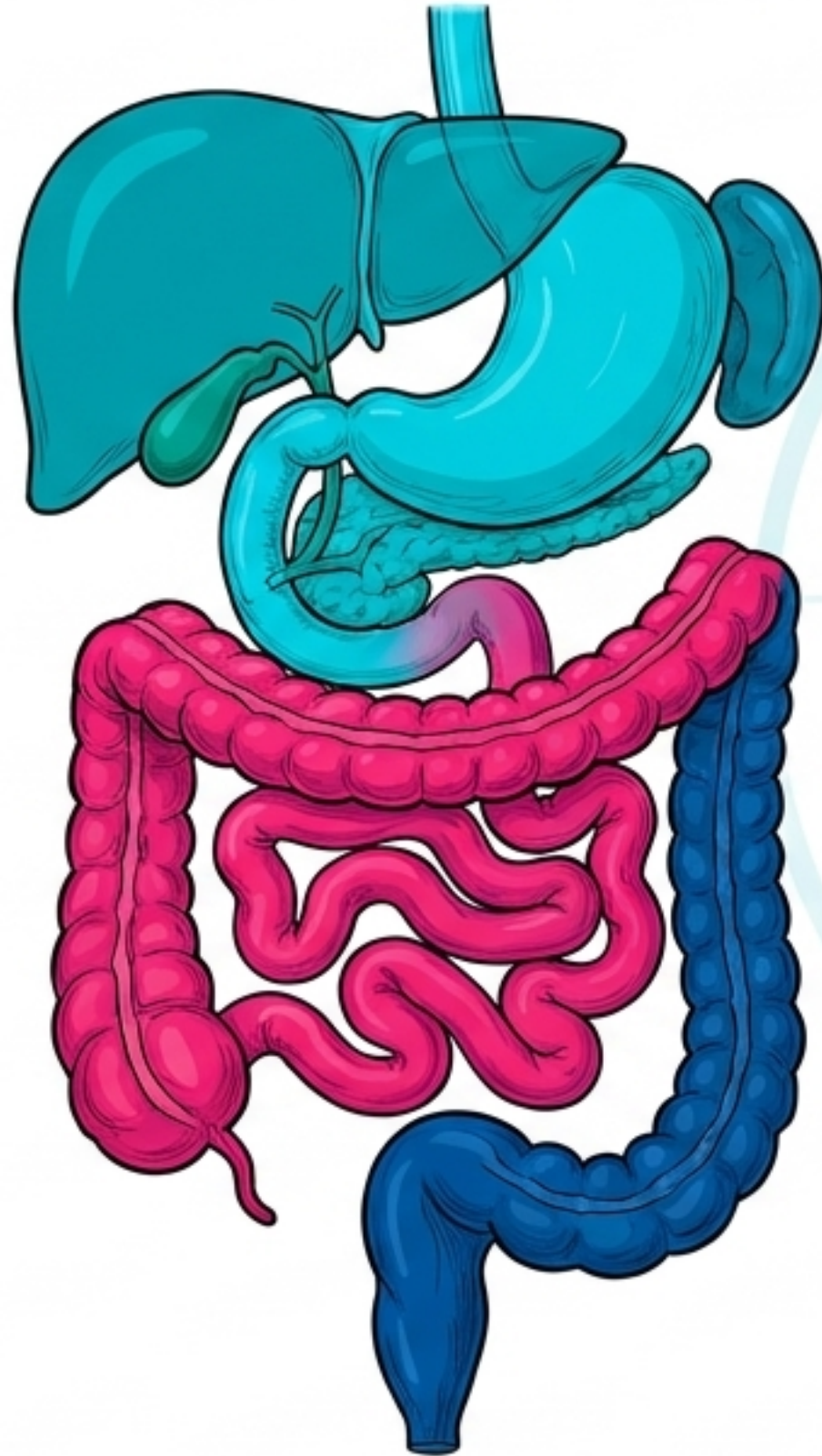
ISQUÉMICO

- Isquemia mesentérica
- Torsión ovárica/testicular
- Hernia estrangulada
- Colitis isquémica

SEMIOLOGÍA DEL DOLOR ABDOMINAL



EMBRIOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN DEL DOLOR VISCERAL



Intestino Anterior → Epigastrio

Órganos: Esófago, Estómago, 1ra/2da porción del duodeno, Hígado, Vías Biliares, Páncreas.

Intestino Medio → Mesogastrio (Periumbilical)

Órganos: 3ra/4ta porción del duodeno, Yeyuno, Íleon, Apéndice vermiforme, Colon ascendente, 2/3 proximales del colon transverso.

Intestino Posterior → Hipogastrio

Órganos: 1/3 distal del colon transverso, Colon descendente, Sigmoides, Recto.



EL ARSENAL IMAGENOLÓGICO: REGLAS DE ORO



Ecografía (Ultrasonido) - Primera Línea

- **Regla:** Gold standard inicial para vesícula biliar y líquido libre (Eco-FAST).
- **Limitación:** El aire es el enemigo del ultrasonido (no evalúa bien el colédoco oculto tras colon/duodeno).



Colangiorensonancia (RM) - El Estándar Biliar

- **Regla:** Examen definitivo para evaluar el colédoco (retroperitoneal) sin interferencia de gas intestinal.



Tomografía (TAC) - Uso Restringido (¡ALERTA!)

- **Corrección Clínica:** NO es de rutina para apendicitis ni vólvulos. Aporta radiación masiva (1 TAC = 164 radiografías).
- **Uso correcto:** Casos dudosos complejos o evaluación de gravedad pancreática a las 48-72 horas. Evitar uso indiscriminado.

EMERGENCIAS INTESITNALES: APENDICITIS Y VÓLVULOS

Apendicitis Aguda (Intervención Inmediata)



- **Diagnóstico:** Puramente clínico + Ecografía de apoyo.
- **Regla Estricta:** Contraindicado el manejo médico aislado (analgésicos/antibióticos enmascarar peritonitis).
- **Tratamiento:** Cirugía laparoscópica temprana.

Vólvulo Sigmoideo (Manejo Escalonado)



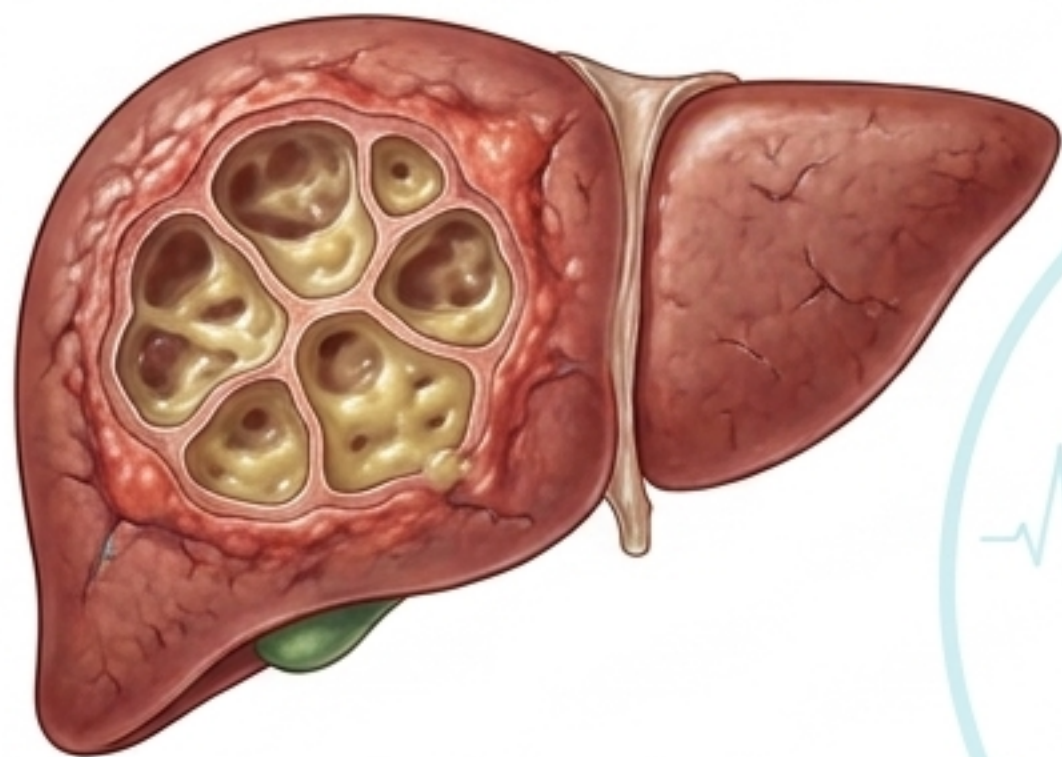
- Rotación del asa sobre su eje.
- **Si NO hay peritonitis ni isquemia:** Tratamiento endoscópico de 1ra línea (Colonoscopia desvolvulativa + tubo rectal). Cirugía de resección electiva posterior.

ALERTA ROJA: Nudo Ileal. Isquemia rápida y estrangulación. Indicación absoluta e inmediata de laparotomía/recepción. NO observar.



ABSCEOS HEPÁTICOS: MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Absceso Hepático Piógeno (Bacteriano)



- **Morfología:** Múltiples tabiques internos (multiloculado).
- **Tratamiento Quirúrgico:** Drenaje laparoscópico urgente o percutáneo.
- **Paso Crítico:** Destrucción mecánica de bridas/tabiques internos para evitar retención de pus. Lavado profuso y colocación de drenes hasta gasto < 20ml/día.

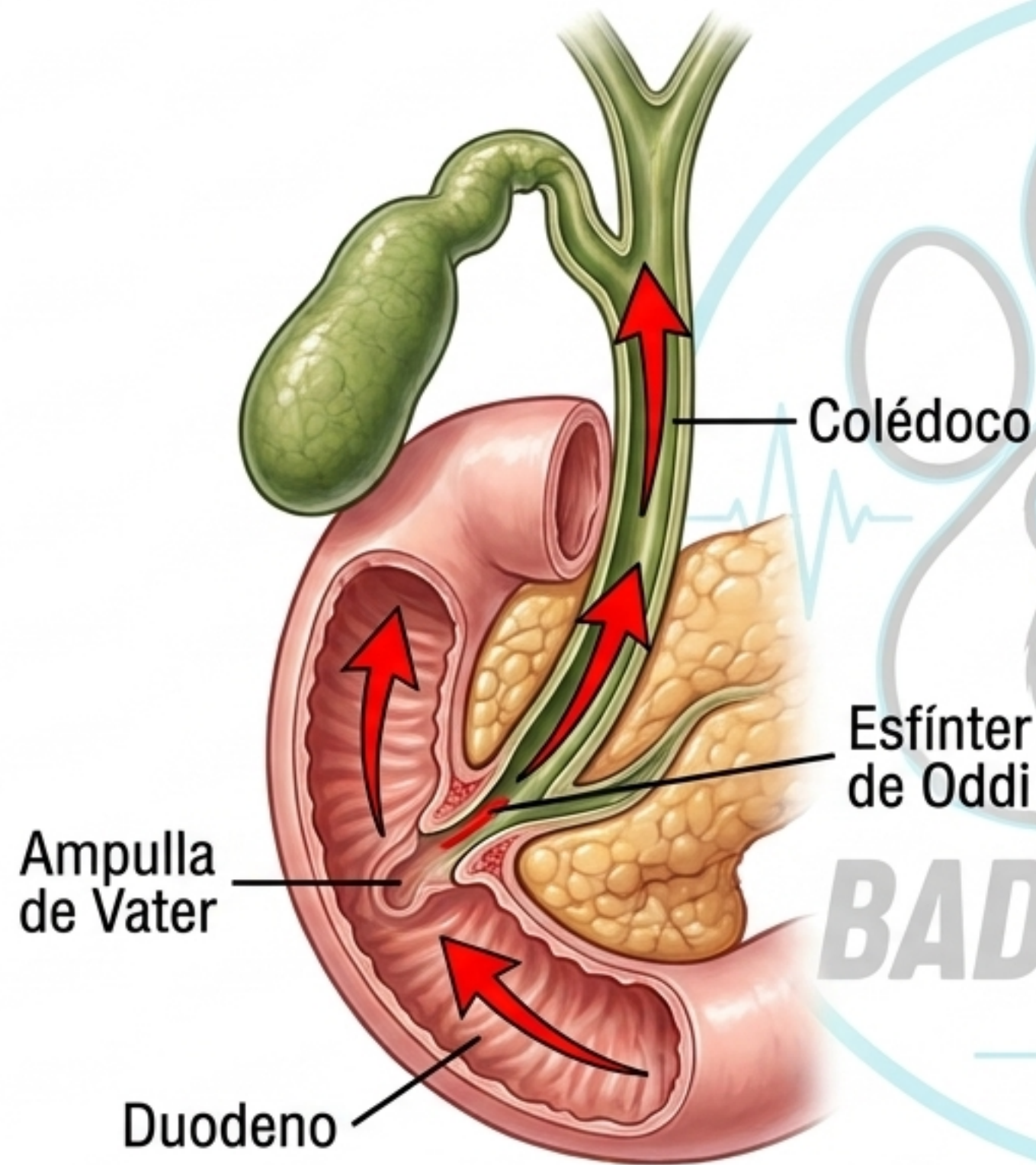
Absceso Hepático Amebiano (Parasitario)



- **Etiología:** *Entamoeba histolytica*.
- **Morfología:** Típicamente unilocular (cavidad única).
- **Tratamiento Médico:** Principalmente farmacológico. Drenaje reservado únicamente para alto riesgo de ruptura o falla clínica. (No requiere ruptura de tabiques).



COLANGITIS: EL MITO DE LA TRANSLOCACIÓN



EL ERROR COMÚN

¡NO es por translocación bacteriana (migración trans-pared)! El intestino intacto no filtra bacterias al colédoco en la colangitis.

FISIOPATOLOGÍA ESTRUCTA (Infección Ascendente)

Es una infección por vía ascendente. Ingresa desde el duodeno a través del conducto natural (Esfínter de Oddi).

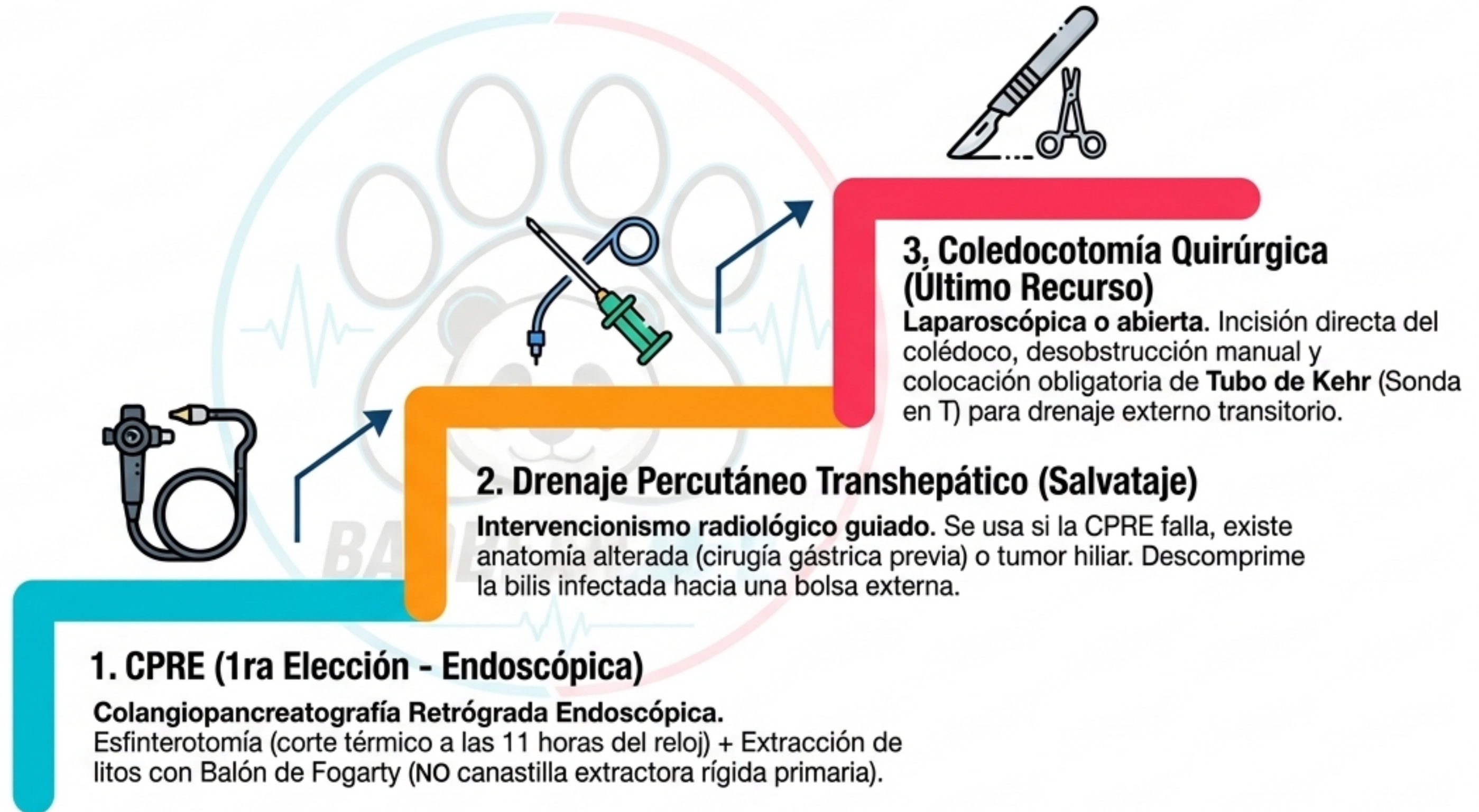
Mecanismos de Defensa Vencidos:

1. Barrera física del esfínter.
2. Presión intraluminal colédociana normal (12-15 cm H₂O). Un cálculo obstructivo eleva la presión masivamente, causando reflujo y bacteriemia sistémica.

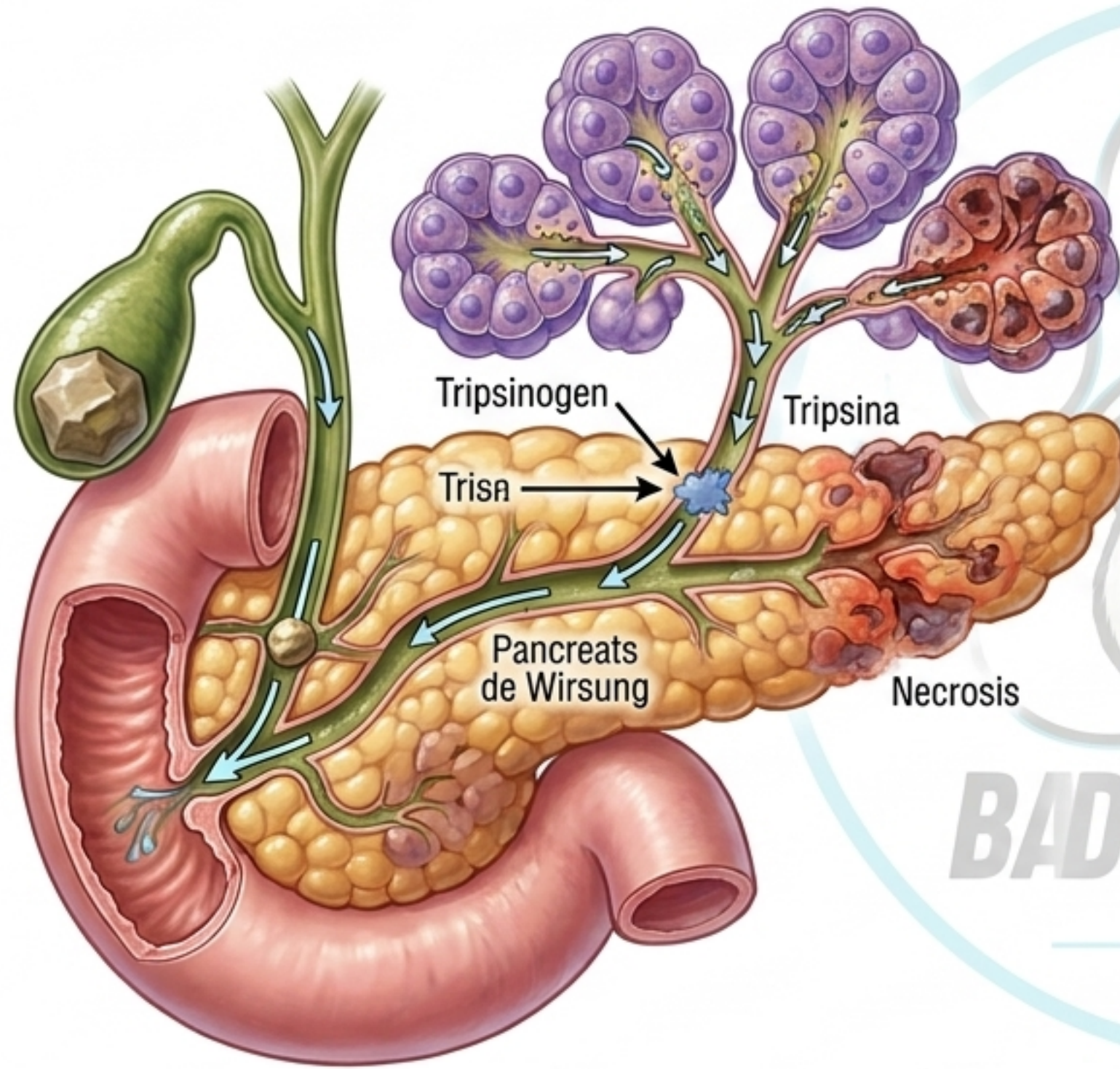
Diagnóstico Clínico: Tríada de Charcot / Péntada de Reynolds.



COLANGITIS: ESCALERA TERAPÉUTICA (STEP-UP APPROACH)



PANCREATITIS AGUDA: ANATOMÍA Y DIAGNÓSTICO



ORIGEN Y ETIOLOGÍA

Afecta al Páncreas Exocrino (acinos/conductos), NO al endocrino.
Causa #1: Litiasis biliar (cálculo atascado en el esfínter genera reflujo hacia el conducto de Wirsung).
Causa #2: Alcoholismo.

FISIOPATOLOGÍA

Reflujo biliar → Daño tisular → Liberación de Fosfolipasa A2 → Activación de Tripsinógeno a Tripsina → Autodigestión (licuefacción del tejido pancreático).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (Requiere 2 de 3)

1. Dolor abdominal típico (epigastrio irradiado en banda dorsal).
2. Lipasa sérica > 3x valor normal (más específica y duradera que la amilasa).
3. Hallazgos imagenológicos compatibles (TAC ideal a las 48-72h).



PANCREATITIS: EVALUACIÓN DE SEVERIDAD

REGLA QUIRÚRGICA DE ORO:

La pancreatitis aguda NO SE OPERA. Se operan EXCLUSIVAMENTE sus complicaciones severas.

Criterios Tomográficos de Balthazar (TAC a 48-72h)

- A:** Páncreas normal
- B:** Edema local/difuso
- C:** Inflamación de grasa peripancreática
- D:** Una colección líquida intra/extrapancreática
- E:** Dos o más colecciones o presencia de gas

Mortalidad y Pronóstico Clínico

- **Extensión de Necrosis:** <30%, 30-50%, >50%
- **Score de Ranson:** Estimación precisa de gravedad y mortalidad.
- **APACHE II:** Criterios predictivos en UCI.



SIGNOS HEMORRÁGICOS RETROPERITONEALES

Signos Patognomónicos de Pancreatitis Necrohemorrágica

Signo de Cullen: Equimosis periumbilical. La sangre viaja y se infiltra a través del ligamento redondo.

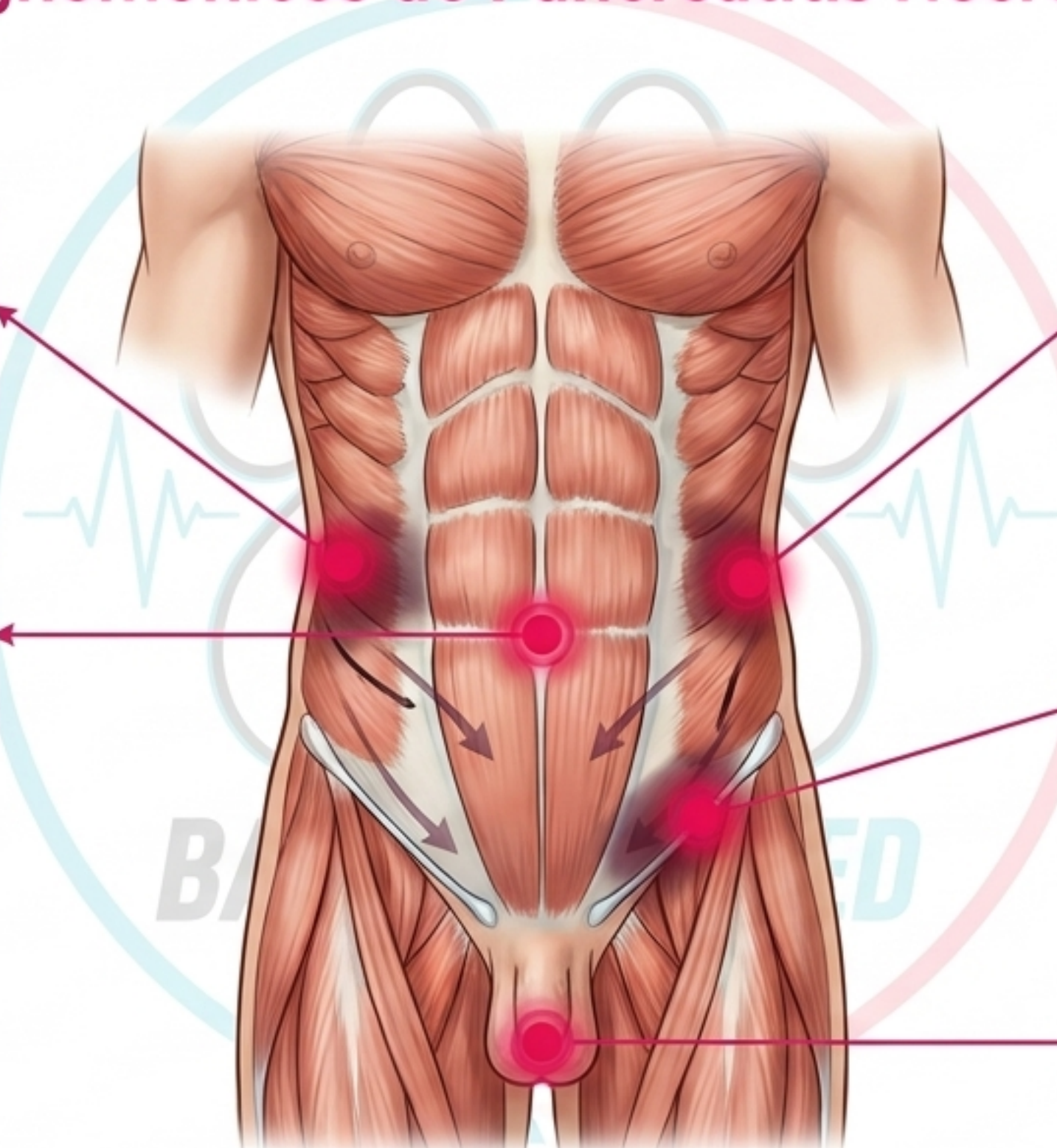
Signo de Grey Turner: Equimosis en flancos bilaterales. La sangre viaja y se infiltra a través del ligamento redondo, o el músculo psoas.

Signo de Grey Turner: Equimosis en flancos bilaterales por difusión retroperitoneal lateral.

Signo de Fox: Equimosis en la región inguinal. La sangre desciende guiada por el ligamento inguinal o el músculo psoas.

Signo de Bryant: Equimosis infiltrada en los genitales externos (escroto/vulva).

(Recordatorio: Es infiltración de sangre, no colección).



COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL PÁNCREAS

1. Pseudoquiste Pancreático

- Complicación más frecuente. Colección estéril.
- **Regla Quirúrgica del Tiempo:** Obligatorio esperar de **4 a 6 semanas** mínimo antes del drenaje (percutáneo, endoscópico o laparoscópico).
- **Razón Fisiológica:** Si se interviene antes, la 'pseudocápsula' fibrosa es frágil y causará un desastre. Necesita engrosarse.

2. Necrosis Infectada / Absceso

- **No** requiere laparotomía abierta cruenta inmediata.
- **Manejo actual:** Step-Up Approach.
- **Progresión:** Drenaje percutáneo inicial → Desbridamiento retroperitoneal mínimamente invasivo asistido por video.

Time-delay logic (Maduración Tisular)



CONCLUSIONES DE CIRUGÍA MODERNA

Laparo-Supremacía

El abordaje laparoscópico (neumoperitoneo con CO2) es el estándar actual absoluto para **diagnóstico** y tratamiento, disminuyendo estancia y morbimortalidad. La laparotomía exploradora 'a ciegas' está **proscrita** en pacientes estables.

Vigilancia de Invasivos (Sondas)

Las sondas **Foley** y nasogástricas ya **NO se usan "por rutina"** en emergencias. Su uso está **estrictamente vigilado y justificado** para evitar infecciones letales intrahospitalarias.

Excelencia Diagnóstica Inicial

La mejor tecnología no reemplaza la anamnesis ni el **examen físico clínico**.

El **éxito del bisturí** y el tratamiento quirúrgico depende de la **certeza diagnóstica inicial**.

PROYECTO BADBEAR.MED - Dominio Absoluto de la Clínica.



BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok

Gemini Notebook